

2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.07.08 암질심 결과 점검

항목	내용
보고일	2026년 7월 9일
회의	2026년 제6차 중증(암)질환심의위원회
회의일	2026년 7월 8일(수)
보고 대상	Korea Market Access / Oncology Leadership
한 줄 결론	6차 암질심은 림카토주와 DCEP 병용요법에 급여기준을 설정하고, 퍼제타주 조기 유방암 보조요법 확대는 재논의로 남겼다.

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 6차 암질심은 국산 CAR-T인 림카토주에 급여기준을 설정하면서 세포치료제 접근성 논의에 의미 있는 기준선을 만들었다. 동시에 DCEP 병용요법은 재발성·불응성 다발골수종에서 급여기준 설정을 받았고, 퍼제타주의 조기 HER2 양성 유방암 수술 전 보조요법 확대는 재논의로 결정됐다.

핵심 메시지	Leadership Implication
림카토주는 5차 암질심에서 미설정된 뒤 이번 6차에서 급여기준 설정으로 전환됐다.	국내 최초 CAR-T의 급여기준 설정은 ATMP·고가 일회성 치료제의 후속 평가와 협상 프레임에 선례가 된다.
DCEP 병용요법은 기존 성분 조합이지만 재발성·불응성 다발골수종에서 급여기준이 설정됐다.	신약뿐 아니라 기존 치료 조합의 급여기준 신설도 환자 접근성과 예산 영향 관점에서 계속 모니터링해야 한다.
퍼제타주는 조기 HER2 양성 유방암 수술 전 보조요법 확대에서 결론을 내지 못했다.	보조요법·장기투여 영역은 임상적 필요와 재정 영향의 균형이 여전히 엄격하게 검토되고 있음을 시사한다.
이번 차수에서 MSD 직접 품목은 확인되지 않았다.	다만 CAR-T, 다발골수종, HER2 유방암 급여기준 변화는 MSD oncology 전략의 경쟁 환경과 comparator 논리에 간접 영향이 있다.

2. 본 차수 심의 결과

구분	품목	회사	대상 질환·신청 내용	심의 결과
요양급여 결정신청	림카토주(안발갑타젠 오토류셀)	큐로셀	두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 및 원발성 종격동 거대 B세포 림프종 성인 환자	급여기준 설정
급여기준 확대	덱사메타손+시클로포스파미드+에토포시드+시스플라틴(DCEP)	해당 없음	재발성 또는 불응성 다발골수종	급여기준 설정
급여기준 확대	퍼제타주(퍼투주맵)	한국로슈	국소진행성·염증성 또는 초기 단계 HER2 양성 유방암 환자의 수술 전 보조요법으로 트라스투주맵 및 화학요법과 병용투여	재논의

주요 해석

- 림카토주: 5차에서 급여기준 미설정이었던 국산 CAR-T가 이번 차수에서 급여기준 설정을 받았다. 후속 절차에서는 약가협상, 위험분담 구조, 장기 추적 근거의 수용 방식이 시장의 관심사가 될 가능성이 높다.

- DCEP 병용요법: 다발골수종에서 기존 성분 조합의 급여기준이 설정됐다. 신약 중심 모니터링만으로는 실제 암질심 agenda를 충분히 설명하기 어렵고, 기존 regimen의 급여기준 신설·확대도 별도 추적이 필요하다.
- 퍼제타주: HER2 양성 조기 유방암 보조요법 확대는 재논의로 남았다. 보조요법은 환자군 규모, 치료기간, 장기 outcome, 기존 급여 범위와의 중복성이 함께 검토되는 영역이다.

3. 시장·정책 시사점

영역	시사점	관찰 포인트
CAR-T·ATMP	림카토주 결과는 국내 개발 세포치료제의 급여기준 설정 가능성을 확인했다.	약가협상 기간, 위험분담 또는 성과기반 조건, 실제 등재 시점
혈액암 치료 접근성	DLBCL·PMBCL 및 다발골수종에서 치료 옵션 접근성이 확대될 수 있다.	고가 치료제와 기존 병용요법의 예산 영향 관리 방식
보조요법 oncology	퍼제타주 재논의는 조기 치료 영역의 급여 확대가 여전히 보수적으로 다뤄질 수 있음을 보여준다.	OS·재발 억제 근거, 환자군 제한, 선별급여 또는 본인부담 구조
위원회 운영	이번 결과는 미설정 약제의 보완 후 재진입, 기존 regimen 확대, 보조요법 재논의가 동시에 나타난 차수다.	차기 암질심에서 재논의·미상정 약제의 재진입 속도

4. MSD 관점의 주요 영향

구분	영향	MSD 대응 관점
직접 품목	이번 차수에서 MSD 직접 품목은 확인되지 않음	직접 action보다는 경쟁 기준선과 후속 급여기준 변화 모니터링 중심
Oncology portfolio	CAR-T·다발골수종·HER2 유방암에서 접근성 변화가 확인됨	키트루다 및 MSD oncology 자산의 comparator, line of therapy, 보조요법 논리에 반영
고가 혁신치료제	림카토주 결과는 고가 일회성 치료의 급여기준 설정과 협상 선례가 될 수 있음	장기효과 불확실성, 재정 영향, 위험분담 구조에 대한 내부 benchmark 추적
보조요법 급여	퍼제타주 재논의는 재정 영향이 큰 보조요법 확대의 높은 증거 기준을 재확인	보조요법 적응증 자료 준비 시 장기 outcome, 환자군 제한, BIA 논리 선제 점검

5. 다음 차수 모니터링 후보

후보	이유	다음 확인 사항
퍼제타주	이번 차수 재논의 결정	보완 자료 제출 여부와 차기 암질심 재논의 여부
임텔트라	소세포폐암 unmet need와 환자 접근성 이슈 지속	실제 재신청·안전화 신호, 급여기준 설정 가능성
티루캡 및 유방암 정밀치료제	HR+/HER2- 유방암 정밀치료 급여 공백 이슈 지속	국내 신청 상태, 보완 근거, 조기·전이성 구분
림카토주	급여기준 설정 후 협상 단계 진입 예상	약가협상 개시, 위험분담 조건, 등재 예상 시점

6. Source & Caveat

본 보고서는 건강보험심사평가원 공식 보도자료의 제6차 중증(암)질환심의위원회 심의결과를 근거로 작성했다. 심의 결과는 후속 고시·약가협상·급여기준 세부 공고 과정에서 적용 범위와 시점이 달라질 수 있다. 본 문서는

leadership 의사결정 지원용 시장 접근성 분석이며, 개별 환자 치료 판단을 목적으로 하지 않는다.